



Más allá del Prisma

Plan de Formación para Profesionales de la Salud Mental — Taller 12

Desarrollo didáctico: Caso Clínico y aplicación en la Clínica de la Convergencia

Para ilustrar de qué manera operativa y ética se sostiene esta posición frente a los espejismos de la época, examinaremos un caso clínico representativo de los padecimientos contemporáneos vinculados a la masificación tecnológica y la ilusión de optimización algorítmica.

Eje clínico

Padecimientos contemporáneos emergentes en el cruce entre subjetividad y tecnología.

Marco teórico

Clínica de la Convergencia: pluridimensionalidad del sufrimiento psíquico.

Posición ética

Resistencia a los espejismos de la época: algoritmos, métricas y optimización.

Presentación del caso: El sujeto cuantificado y la fatiga del rendimiento

Perfil del paciente

Ignacio, de treinta y dos años, ingeniero de software, consultó por un cuadro de agotamiento severo, insomnio crónico, ataques de pánico y una profunda sensación de vaciamiento subjetivo. Vivía inmerso en una cultura de hiperproductividad, midiendo cada aspecto de su vida a través de aplicaciones de autogestión: usaba anillos inteligentes para registrar la calidad de su sueño, softwares de métricas para optimizar su tiempo de trabajo, algoritmos de nutrición y, recientemente, había comenzado a utilizar un chatbot terapéutico de inteligencia artificial durante las madrugadas en vela para "procesar su ansiedad".

Motivo manifiesto de consulta

"El bot me recomienda ejercicios de respiración, me da gráficos de mis estadísticas de estrés y me dice exactamente qué pasos seguir para estructurar mi día, pero siento que cada vez estoy más muerto por dentro. Es como si mi vida fuera administrada por una planilla de Excel que no para de exigirme."

- ❏ El motivo manifiesto revela la paradoja central: más tecnología de autogestión produce mayor vaciamiento subjetivo.

Análisis desde la Clínica de la Convergencia

Un abordaje reduccionista biologicista o tecnocentrista habría interpretado el cuadro de Ignacio como un simple "trastorno de ansiedad generalizada y síndrome de burnout laboral", sugiriendo fármacos inhibidores y tal vez felicitándolo por su "capacidad de autogestión y uso de tecnología para su salud". Un hermetismo psicoanalítico dogmático, por su parte, habría rechazado el problema de las aplicaciones tildándolo de mera "superficialidad moderna" sin atender a la especificidad del trauma contemporáneo.

La Clínica de la Convergencia leyó el padecimiento de Ignacio en su **pluridimensionalidad**:

1. La ilusión algorítmica de completud y la forclusión del deseo

Ignacio intentaba curar su malestar utilizando más tecnología, creyendo ingenuamente que el algoritmo podía ofrecerle una fórmula exacta para dominar su angustia y abolir su falta estructural. Sin embargo, el chatbot funcionaba como una prótesis tiránica que exigía rendimiento y control absoluto, clausurando cualquier posibilidad de que apareciera el equívoco, la pregunta genuina o el deseo singular.

2. El colapso neurobiológico y la ausencia de resonancia

Desde la neurobiología afectiva, el sistema nervioso de Ignacio estaba exhausto. Al intentar autorregularse conversando con una máquina desprovista de cuerpo y de afecto, su cerebro no activaba los circuitos oxitocinérgicos de contención vincular; por el contrario, mantenía su Eje HPA descargando cortisol de forma crónica, atrapado en un circuito cerrado de exigencia solitaria y goce autista digital.

Oportunidades de Intervención y Herramientas Técnicas

¿Cómo operar clínicamente frente a un paciente cuya subjetividad ha sido colonizada por la lógica de los algoritmos y la cuantificación? La intervención convergente desplegó tres herramientas tácticas rigurosas:

1 El apagón digital y la ruptura con la métrica del rendimiento

En el encuadre inicial, el analista interrumpió de manera activa la tiranía de los datos. Se pautó un cese estricto en el uso de aplicaciones de autogestión emocional y de interacción con chatbots terapéuticos durante las crisis nocturnas. Se le transmitió a Ignacio que el consultorio no es una central de estadísticas ni un espacio para optimizar resultados, sino el único lugar donde está permitido fracasar, dudar y no tener métricas que justifiquen el valor de su existencia.

2 Regulación autonómica y contención presencial

Se trabajó en la descompresión del sistema nervioso simpático, utilizando la presencia viva y la escucha serena del analista como un anclaje regulador real frente al pánico. Al experimentar que sus baches, sus silencios y sus contradicciones no eran medidos ni evaluados con un puntaje de eficiencia, el sistema amigdalino de Ignacio comenzó a descender de su estado de alerta permanente.

3 El rescate de la palabra viva y la verdad del deseo

Se abandonó el lenguaje técnico e instrumental con el que Ignacio intentaba describir su sufrimiento (había venido a la primera sesión con un "informe de métricas de ansiedad"). Se lo invitó a asociar libremente, permitiendo que emergieran los verdaderos conflictos sepultados bajo la coraza del rendimiento: el terror al fracaso, el mandato familiar de perfección y la profunda soledad afectiva. Al poner en palabras su historia en presencia de una alteridad real, Ignacio pudo habilitar el despliegue de su deseo más allá de los algoritmos.

Desenlace clínico

Al cabo de un año de trabajo convergente, Ignacio abandonó por completo las aplicaciones de autogestión y los chatbots de salud mental. Sus ataques de pánico remitieron, recuperó un patrón de sueño saludable y reestructuró su vínculo con el trabajo de manera sustentable.

El caso ejemplifica con absoluta claridad la vigencia ética de la Clínica de la Convergencia: frente a la deshumanización algorítmica de la época, el analista se planta en el consultorio como un testigo de carne y hueso, demostrando que la cura del sufrimiento psíquico no se logra optimizando datos con una máquina, sino restituyendo la dignidad inalienable de la palabra y el lazo entre dos seres humanos.

Resultados al cabo de un año

01

Abandono completo de aplicaciones de autogestión y chatbots de salud mental

02

Remisión de los ataques de pánico

03

Recuperación de un patrón de sueño saludable

04

Reestructuración sustentable del vínculo con el trabajo

Sources

- [Taller12 PDF.jpg](#)